

AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA

Aida García Rúa, Elena Ameijide Sanluis, Ciara García Fernández, Esther Suárez Sanmartín.

INTRODUCCIÓN

La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome definido por un trastorno selectivo de la memoria de inicio brusco y resolución completa en menos de 24 horas. Se caracteriza por:

- Leve afectación de la memoria retrógrada
- Severa afectación de la memoria anterógrada
- Preguntas repetitivas
- Ausencia de otros signos neurológicos focales o comiciales

La edad media de presentación es de 60-65 años. No existen diferencias significativas en la distribución por género.

El mecanismo fisiopatológico de la AGT es una disfunción transitoria del hipocampo y estructuras parahipocámpicas, sin que se haya logrado consenso respecto a la etiología. Se han postulado diferentes hipótesis causales: isquemia arterial, congestión venosa, comicial o migrañosa.

La mayoría de los pacientes presentan un único episodio a lo largo de su vida. Se han descrito recurrencias hasta en un 8% en cohortes con seguimiento a largo plazo.

La AGT es una entidad benigna que no implica un mayor riesgo de mortalidad, epilepsia, ictus o demencia. La importancia de su diagnóstico radica en excluir otras patologías que cursan con amnesia y que pueden ser potencialmente graves.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la AGT es clínico y de exclusión. Es recomendable realizar entrevista a testigos para recabar información sobre el inicio y desarrollo del cuadro.

Factores Precipitantes

En el 90% de los casos se identifica un factor precipitante. Los más frecuentemente descritos son:

- Estrés emocional
- Esfuerzo físico
- Dolor intenso
- Maniobras de Valsalva
- Inmersión en agua (especialmente a baja temperatura)
- Otros: procedimientos médicos, cambios posturales, actividad sexual, altitudes elevadas...

Características Clínicas

- Duración del episodio menor de 24 horas (de media 6 horas).
- Afectación de la memoria anterógrada de inicio brusco con incapacidad para retener nueva información:
 - Inicialmente realizan preguntas y comentarios repetitivos
 - Progresivamente se restaura la capacidad para adquirir nuevos recuerdos
 - Puede persistir amnesia lacunar circunscrita al episodio.
 - Afectación de la memoria retrógrada de intensidad variable con imposibilidad para recordar hechos recientes (horas, días o semanas previas). Este déficit suele resolver completamente.

- Sin pérdida de memoria autobiográfica
- Puede existir desorientación temporo-espacial sin otras alteraciones cognitivas.
- Se mantiene la atención y el nivel de alerta.
- Preservación de capacidad para conversar, leer y realizar tareas motoras complejas (conducir, cocinar...)
- No aparecen signos ni síntomas neurológicos focales. Puede acompañarse de cefalea, mareo y náuseas.
- No epilepsia activa ni signos sugestivos de comicialidad.
- No traumatismo cráneo-encefálico reciente.

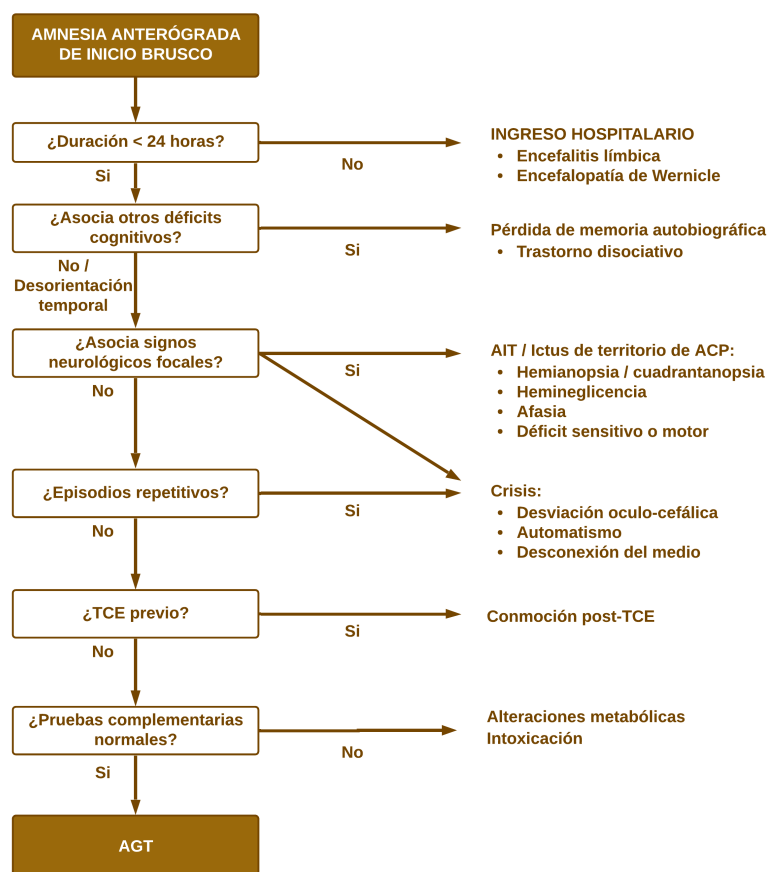
Pruebas Complementarias

No existen pruebas confirmatorias. Los estudios complementarios están orientados a descartar diagnósticos alternativos.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, screening toxicológico.
- Gasometría arterial si se sospecha intoxicación por CO.
- TC o RM según disponibilidad en el Servicio de Urgencias.
- Electroencefalograma: en caso de episodios recurrentes o clínica sugestiva de comicialidad.

Diagnóstico Diferencial

- Ataque isquémico transitorio (AIT)
 - Se acompaña de síntomas focales: disartria, nistagmus, ataxia, alteración sensitivo-motora o déficits campimétricos.
- Amnesia epiléptica transitoria (AET)
 - Episodios más breves (menos de 1 hora) y recurrentes, que aparecen frecuentemente al despertar.
 - Pueden asociar automatismos motores y alucinaciones olfatorias o auditivas.
- Amnesia disociativa o psicógena
 - Pacientes más jóvenes,
 - El inicio del cuadro coincide con un acontecimiento con impacto emocional intenso.
 - Afectación selectiva de la memoria retrógrada, mostrando característicamente una pérdida de la identidad personal.
 - Puede prolongarse desde unas horas hasta meses.
- Conmoción post-traumatismo cráneo-encefálico (TCE)
 - El antecedente de TCE al inicio del cuadro excluye el diagnóstico de AGT, incluso en ausencia de lesiones cerebrales visibles en pruebas de neuroimagen.
- Otros: Intoxicación por CO, hipoglucemia, consumo o privación de alcohol o drogas, toxicidad farmacológica, encefalopatía, demencia.



TRATAMIENTO

- No requiere tratamiento específico. Dirigido a tratar la causa que lo desencadena.
- Unidad de Observación hospitalaria hasta la resolución del cuadro.
- Explicar la benignidad del cuadro al paciente y su familia.
- No implica restricciones legales en la conducción de vehículos.
- Ingreso hospitalario si persiste después de 24 horas o se detectan signos/ síntomas atípicos.

PUNTOS CLAVE

- Amnesia anterógrada de inicio brusco que resuelve en < 24 horas.
- Preguntas reiterativas: “¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué hora es?”
- Sin déficits focales en la exploración neurológica.
- Sin signos sugestivos de etiología epiléptica.
- Sin alteraciones agudas/subagudas en la neuroimagen.
- No requiere tratamiento.
- Buen pronóstico.

	AGT	AIT	AET
Factores de riesgo	No / ¿migraña?	Factores de riesgo vascular	Diagnóstico previo de epilepsia
Factores precipitantes	Valsalva, emociones, ejercicio físico, inmersión	No	Transición sueño-vigilia
Duración	4-6 horas (<24 horas)	<60 min (<24 horas)	<60 min
Síntomas neurológicos asociados	Cefalea, mareo. No déficits focales.	Déficits focales: hemianopsia, nistagmus, hemiparesia, ataxia.	Versión oculocefálica, automatismos motores, desconexión del medio.
Recurrencia	Infrecuente	Intermedia	Frecuente
Pruebas complementarias	Análítica, TC craneal	Análítica, TC craneal, Eco-TSA / DTC, Holter	Análítica, TC craneal, EEG

Amnesia epiléptica transitoria: **AET**. Ataque isquémico transitorio: **AIT**. amnesia global transitoria: **AGT**

BIBLIOGRAFÍA

- Spiegel, D., Smith, J., Wade, R., Cherukuru, N., Ursani, A., Dobruskina, Y., Crist, T., Busch, R., Dhanani, R. and Dreyer, N. (2017). Transient global amnesia: current perspectives. Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volume 13, pp.2691-2703.
- Arena JE, Rabinstein AA. Transient global amnesia. Mayo Clin Proc. 2015 Feb;90(2):264-72.
- Kremen S, Mendez M, Wilterdink J. Transient global amnesia. [Monografía en Internet]. UpToDate; [revisado en febrero 2018]. Disponible en: <http://www.uptodate.com>
- Markowitsch, H. and Staniloiu, A. (2012). Amnesic disorders. The Lancet, 380(9851), pp.1429-1440.